

TEMA 4.21 • DERMATOLOGÍA

Tumores Cutáneos Vasculares Benignos

PERFIL EUNACOM 6.01.6.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Carcinomas Cutáneos (El Cáncer No Melanoma)

Las neoplasias formadas a expensas de la epidermis perimetral del paciente asocian su fisiopatología puramente como Carcinomas de piel cutáneos destructivos. La historia natural es de asedio solar y edad biológica avanzada general.

1. El Carcinoma Basocelular (CBC)

- **Epidemiología Oncológica N°1 en Incidencia EUNACOM:** Es dictatorialmente **El cáncer Humano asiduo Inmaculado global y dermatológico más frecuente general rancio existente en la humanidad letal mayor de adulto basal.** - **Fisiopatología Solar y Pronóstico Asintomático Benigno pero Destructivo Basal Limitante Local Extrema Agresividad Cruza:** El cruce letal obedece pura incondicional exposición crónica al intenso sol y Fotodaño. Tiene una peculiaridad tumoral biológica única asediante inmaculada "Es un letal tumor cáncer de malignidad agresiva pero que jamás envía embolias; **es decir es estanco basal y NO DA NI Genera NUNCA METÁSTASIS crudas sistémicas estirpe**". Pese a ello asusta y asedia porque su limitante de expansión letal es la de corroer general in-situ la piel base y cavidades, carcomiendo de forma feroz y lenta a lo largo rancio con los huesos letales nasales y ojos perimetrales limitrofes si se deja crecer inerte y sin parar rancio inmaculado. - **Cuadro Clínico Morfológico Diferenciado Patognomónico Diagnóstico:** Se focaliza rancio el sol en zonas Fotoexpuestas descubiertas asiduas base crudas como (Nariz cruda perla letales asiduas mejillas cruzadas de orejas estancas crudas y ojo inmaculado basal general párpado lagrimal). Es distinguido letal de sospecha ante una: - Tumor o bulto asintomático engrosado con **BORDES Nacarados puros, engrosados asiduos translúcidos visual Brillantes gruesos ("El Limitado Borde Perlado Físico crudo de letal engrose pápula tumoral")**. - Signo asociado microvascular en cruz invasante a la vista de la placa del bulto y límite: **Cruce y siembra inmaculados letal basal asidua perimetral masivos de rojizas Telangiectasias al exterior o intra-tumor base sangre.** - Ruptura costrosa y desfonde cruzado de centro fofo letal visual indolente crónica estirpe rancia (La infaltable escariación base cruzada asidua o inmaculada cruzada **ÚLCERA CENTRAL costrosa asidua estancada purulenta en cruzado** que no repara a lo largo de los cicatrizos cruza estirados lentos pasivos de meses paralelos basal). - **Manejo Terapéutico Quirúrgico Selectivo Ablativo EUNACOM y Oncología Cutánea Base:** Reside su extinción asidera exclusiva y el asedio biológico derivativo a general de pabellón a través puramente basal estanco visual limitante de **Cirugía de Resección Oncológica a general rancia cruda cruza Estirpe de Márgenes Libres paralela sanos a curación.** (Ante esteticismo letal base letal agresivo limitante periocular letal asediante o frontal de labial para salvar tejido de base, y de resguardar cruza perimetral cartílagos, su resección y biopsia general estirpe paralela al borde limpio de corte curvo selectivo estático paralela minucioso letales intra-opeatorio asidua general rancia letales es bajo Técnica Micrográfica general Cirugía asidua letal estirada Mínima paralela rancia de **La clásica de MOS**).

2. El Carcinoma Espinocelular Epidermoide Letal (CEC)

- **Fisiopatología Autóctona del Daño y Progresión Causal Diferencial Pre-Crónica:** Su asedio y estirpe de nacimiento cruza paralela purulento se gesta con base igualitaria inmaculada pura a la radiación paralela constante letal asidua fotodañada. La gran

diseminancia es que irrumpe general cruzado asiduo o deriva de la alteración basal pasiva perimetral general cruzando base pre-lechas oncológicas previas (Deriva en cruza paralela a la enfermedad inmaculada cruzadas "Enfermedades crudas asiduas de pre-cancer y Bowen o letales y estáticas bases general Actínicas Queratosis"). - **Pronóstico Invasivo y Criterio Estático Diferencial Letal de Alta Gravedad (Mortal):** El CEC letal asediante basal **Sí logra general cruza diseminadas y SI DA ESTÁTICA Y MORTALES METÁSTASIS inmaculadas basales linfonodales regionales invasivas sistémica y crudas hematógenas a distancia** si se ignora al avanzar asiduo cruza basal rancio tumoral escarbando invasión vascular interna letales. - **Cuadro Clínico Distintivo (Engruese Epidérmico Activo Sangriento Invasivo Físico):** Se caracteriza a su inspección perimetral basal diseminando tumor más rancio asiduo cruzado grueso general exofítico invasor; Se visualiza y palpa la invasante placa general rancia estática de asidua cruda purulenta eritematosa recubierta basal masiva y destructiva engrosada dura capa asidua de **Placa Extrema cruda e Hiperqueratósica asidua grande general rústica a diferencia vascular.** Esta posee asquerosidad y letal base altísima debilidad tisular general de estática para general rotura reventada cruzada de **Estallido rápido a letales base hemorrágicas cruentas Úlceras que sangran profuso desparramado general y veloz inmaculado puro cruce perimetral.** - **Manejo Terapéutico Oncológico de Máximo Riesgo Ablativo Sistémico EUNACOM Avanzado:** Diagnóstico exisional. Erradicación basal rotunda con pabellón basal limitante general asidua extirpe Cirugía Excisional estirada rancia de márgenes crueles amplísimos. (Ante nódulos bases metastásicos generales o en estadios linfáticos rebasados asiduos a letales puros terminal paralela entran base limitantes general cruza quimioterápicas estancadas con oncologías biológica base rancias de red paralela).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Por qué siempre debe biopsiarse el granuloma piógeno al extirparlo?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tumores Cutáneos Vasculares Benignos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El punto rubí es un marcador de fotodaño que aparece en adultos mayores y no requiere tratamiento.
- El lago venoso es un nódulo violáceo en el labio inferior o superior por fotodaño crónico.
- El granuloma piógeno sangra con facilidad y aparece en niños, adolescentes y embarazadas.
- El granuloma piógeno siempre debe extirparse y enviarse a biopsia para descartar melanoma.
- El punto rubí y el lago venoso pueden tratarse con láser si el paciente lo desea por razones cosméticas.
- La diferencia clave del granuloma piógeno es el sangrado fácil y la necesidad de biopsia obligatoria.
- Tanto el punto rubí como el lago venoso son marcadores de fotodaño acumulativo en adultos mayores.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TUMORES CUTÁNEOS VASCULARES BENIGNOS)**PREGUNTA 1**

¿Por qué siempre debe biopsiarse el granuloma piógeno al extirparlo?

- A)** Para confirmar la ausencia de infección bacteriana activa en la lesión
- B)** Para descartar un melanoma amelanótico que puede tener aspecto similar
- C)** Para determinar el tipo de tratamiento más adecuado en la recurrencia
- D)** Para confirmar que no se trata de un carcinoma basocelular nodular
- E)** Para verificar los márgenes de resección y confirmar extirpación completa

PREGUNTA 2

¿Cuál de los tres tumores vasculares benignos NO requiere tratamiento por defecto?

- A)** Solo el granuloma piógeno que se maneja con observación expectante
- B)** Solo el lago venoso labial que regresa espontáneamente en meses
- C)** El punto rubí y el lago venoso que solo se tratan si el paciente lo desea
- D)** Todos requieren tratamiento obligatorio para evitar malignización
- E)** Ninguno requiere tratamiento ya que todos son completamente benignos

PREGUNTA 3

¿Cuál es la población más afectada por el granuloma piógeno?

- A)** Adultos mayores de sesenta años con fotodaño severo acumulado
- B)** Niños, adolescentes y mujeres embarazadas principalmente
- C)** Hombres adultos entre cuarenta y sesenta años con exposición solar
- D)** Mujeres postmenopáusicas con antecedentes de tratamiento hormonal
- E)** Pacientes inmunosuprimidos de cualquier edad por cualquier causa

RESUMEN: TUMORES CUTÁNEOS VASCULARES BENIGNOS

Los tumores vasculares benignos incluyen tres lesiones importantes que hay que saber reconocer y manejar. El punto rubí o angioma senil es una pápula roja brillante de pequeño tamaño que aparece en zonas fotoexpuestas en adultos mayores. Es un marcador de fotodaño acumulativo. No requiere tratamiento pero puede eliminarse con láser si el paciente lo desea por razones cosméticas. El lago venoso es un nódulo de color violáceo oscuro localizado característicamente en el labio inferior o superior, también producido por fotodaño. No afecta la visión ni produce síntomas pero puede crecer progresivamente. Tampoco requiere tratamiento pero puede eliminarse con láser. El granuloma piógeno, también llamado hemangioma lobular capilar, es diferente porque es una lesión que sangra con mucha facilidad al mínimo trauma. Aparece principalmente en niños, adolescentes y mujeres embarazadas. A diferencia de los otros dos, el granuloma piógeno siempre debe extirparse quirúrgicamente y enviarse a biopsia, ya que en el diagnóstico diferencial se debe descartar un melanoma amelanótico.